

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

JUST CULTURE E GESTIONE DEL NEAR MISS

Cultura della segnalazione no-blame, distinzione errore sistemico vs violazione, debrief team (ISO 7101 §6.4)

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO111_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Risk Manager Clinico / Medico Direttore Sanitario	AD – Francesco Epifani	Distribuita a tutto il personale clinico e di laboratorio	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e principi fondanti

La presente procedura definisce il modello di Just Culture adottato da Toscana Diagnostica per la gestione degli errori, dei quasi-errori (near miss) e degli eventi avversi nel processo clinico-diagnostico. Il modello si fonda sui principi della no-blame culture: distinzione sistematica tra errore umano (involontario, sistemico), comportamento a rischio (consapevole ma con percezione di controllo) e violazione (consapevole e intenzionale). I quattro principi cardine della Just Culture in TD sono: (1) ogni segnalazione di near miss è un dono al sistema; (2) chi segnala in buona fede non viene mai sanzionato; (3) gli errori sistemici sono problemi del processo, non delle persone; (4) la trasparenza è un dovere etico verso il paziente e verso i colleghi.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Pertinenza
ISO 7101:2023 §6.4	Cultura della sicurezza e gestione degli eventi avversi
ISO 7101:2023 §10.2	Non conformità e azioni correttive in ambito clinico
ISO 9001:2015 §10.2	Non conformità e azione correttiva (framework generale)
Raccomandazioni AGENAS Patient Safety	Linee guida nazionali sulla sicurezza del paziente
L. 24/2017 (Gelli-Bianco)	Sicurezza delle cure e responsabilità professionale
Reason J. (1997) "Managing the risk of organisational accidents"	Modello swiss cheese, distinzione errore attivo vs latente
Marx D. (2001) "Patient Safety and the Just Culture"	Algoritmo decisionale per distinguere errore/comportamento/violazione

3. Definizioni operative

Termine	Definizione
Evento avverso (EA)	Danno conseguente al processo di cura, non legato alla patologia di base
Near miss	Evento che avrebbe potuto causare danno, ma è stato intercettato in tempo
Errore umano	Azione o omissione involontaria che ha portato a un risultato non desiderato
Comportamento a rischio	Scelta consapevole di una pratica con margine di rischio (es. shortcut)
Violazione	Deviazione consapevole e ingiustificata da una procedura nota
Errore sistemico	Errore prodotto da fattori organizzativi/strutturali, non dal singolo operatore
Just Culture	Cultura organizzativa che bilancia accountability individuale e responsabilità sistemica
Open Disclosure	Comunicazione trasparente al paziente di un evento avverso (rif. PRO093)

4. Albero decisionale per la classificazione

Quando si verifica un evento o si riceve una segnalazione di near miss, il Risk Manager Clinico applica il seguente albero decisionale (algoritmo di David Marx):

Step 1 — L'operatore ha intenzionalmente causato il danno? Sì → procedimento disciplinare. No → step 2.

Step 2 — L'operatore ha agito sotto effetto di alcol/sostanze? Sì → procedimento disciplinare + supporto. No → step 3.

Step 3 — L'operatore ha consapevolmente violato una procedura nota e applicabile, senza giustificazione? Sì → richiamo + retraining. No → step 4.

Step 4 — L'operatore ha scelto un comportamento a rischio (shortcut)? Sì → coaching + revisione del processo (perché la scorciatoia era vista come accettabile?). No → step 5.

Step 5 — Si tratta di errore umano? In tal caso: nessuna sanzione individuale; analisi sistemica (RCA) per identificare cause profonde; revisione della procedura.

5. Procedura operativa

Step	Attività	Responsabile	Output
1	Segnalazione spontanea di near miss/EA da qualsiasi operatore (anche anonima)	Operatore segnalante	MOD209 ICPS o canale anonimo
2	Triage entro 24h: classificazione preliminare (near miss / EA / sentinel event)	Risk Manager Clinico	Classificazione registrata su MOD209
3	Apertura indagine: SEA (Significant Event Audit) o RCA (Root Cause Analysis) per gli eventi rilevanti	Risk Manager Clinico + DT Lab	PRO092 attivato
4	Applicazione albero decisionale Marx per la responsabilità	Risk Manager Clinico + Comitato Sicurezza Cure	Decisione documentata
5	Debrief team multidisciplinare (entro 7gg per eventi rilevanti)	Risk Manager Clinico	Verbale di debrief
6	Definizione azioni correttive (sistemiche prevalenti)	Risk Manager Clinico + responsabili coinvolti	Piano azioni
7	Open Disclosure al paziente (se EA con danno)	DT Lab + medico responsabile	PRO093 attivato
8	Aggiornamento Cruscotto Patient Safety (MOD210)	Risk Manager Clinico	KPI aggiornati
9	Verifica efficacia azioni a 90 giorni	Risk Manager Clinico	Chiusura segnalazione
10	Riesame trimestrale Comitato Sicurezza Cure: trend, sistematicità, formazione	Direzione Sanitaria	Verbale + indicazioni AD

6. Tutele del segnalante

- Il segnalante in buona fede non è mai sanzionato per il fatto della segnalazione, anche se la segnalazione si rivela infondata o erranea.
- Il sistema di segnalazione consente l'anonimato a richiesta.
- I dati della segnalazione sono trattati con riservatezza, accessibili al solo Risk Manager Clinico e al Comitato Sicurezza delle Cure.
- La segnalazione è separata e indipendente dal canale Whistleblowing (PRO003), che riguarda condotte illecite, non eventi clinici.

- Il segnalante riceve feedback (anche se ha scelto l'anonimato, attraverso comunicazioni generali al team) sulle azioni intraprese.

7. KPI Just Culture

KPI	Target	Frequenza
Numero di segnalazioni near miss / mese	Trend in crescita (segnale di maturità della cultura)	Mensile
% segnalazioni anonime sul totale	In riduzione nel tempo (segnale di fiducia crescente)	Trimestrale
Tempo medio dalla segnalazione alla classificazione	< 24 h	Mensile
Tempo medio dalla segnalazione al debrief	< 7 gg per eventi rilevanti	Mensile
% azioni correttive verificate efficaci a 90gg	> 80 %	Trimestrale
Survey "psychological safety" (Edmondson scale)	> 4,0 su scala 1-5	Annuale
Eventi sentinella (ricorrenti dopo azione correttiva)	0	Continuo

8. Formazione e cultura

- Modulo Just Culture obbligatorio per tutto il personale clinico e di laboratorio (4h annue), incluso negli obblighi formativi (PRO029).
- Walking round mensili della Direzione Sanitaria nei reparti operativi per ascolto attivo.
- Pubblicazione interna trimestrale "Storie di near miss" (anonimizzate) per condivisione di apprendimenti.

9. Riferimenti documentali

Codice	Documento
TD-SGI-MOD209	ICPS - Incident Reporting System
TD-SGI-MOD210	Cruscotto Indicatori Patient Safety
TD-SGI-PRO092	Significant Event Audit / Root Cause Analysis
TD-SGI-PRO093	Open Disclosure di eventi avversi al paziente
TD-SGI-PRO003	Whistleblowing (canale separato)
TD-SGI-PRO029	Formazione Aziendale
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	04/05/2026	Prima emissione: framework Just Culture, albero decisionale Marx, procedura a 10 step, KPI cultura.	AD / DS / RSGI